LABORATORIO 2 DE MODELAMIENTO DE PROCESOS

1. **Cita en consultorio Externo**

   Hablamos de un centro médico con unas cuantas especialidades y servicios de pruebas médicas.

- Los pacientes deciden, consultando un cuadro médico, qué especialista o médico de familia quiere visitar en consulta médica. El centro funciona estableciendo una duración fija a cada consulta (15 minutos) y un número máximo de consultas. También ofrece servicios de recordatorios periódicos al cliente. Por último registra la comparecencia del cliente que debe confirmar en el mostrador de recepción su llegada al centro. El servicio también contempla la posibilidad de cancelaciones y modificaciones.

- Ahora mismo, todo se hace en papel y hay 2 recepcionistas al cargo tanto del teléfono como de la atención directa en mostrador. Más o menos mantienen un cuadro único que se van rellenando entre los dos.

- El paciente puede llamar por teléfono o acudir presencialmente a recepción para solicitar la cita. No hay un área específica para citas, el personal de recepción se encarga indistintamente de todas las gestiones de su puesto.

- Una vez elegida la cita (médico o servicio, día y hora) tras comprobar su disponibilidad, se anota en un cuadrante organizado por esos mismos parámetros. Se supone que el cuadrante abarca un periodo de tiempo suficientemente amplio. El paciente recibe una confirmación verbal de su cita programada, a veces se le escribe una nota como recordatorio.

- También se dan citas a los servicios de pruebas médicas, que pueden ser resultado de alguna consulta previa. En este caso, el paciente es enviado por el médico al mostrador de recepción para que le programe una prueba en el servicio correspondiente. El paciente presenta un volante del médico, recepción busca huecos en el servicio demandado y consensúa con el paciente una cita. Por lo demás es el mismo proceso de cita.

- Dos días antes, si el intervalo de tiempo es mayor, al paciente se le recuerda su cita mediante llamada telefónica o SMS, si el paciente ha suministrado el dato necesario.

- Diariamente se confecciona una lista de consultas a cada médico o servicio, con la programación de citas para el día siguiente.

- El día de la consulta, sea del tipo que sea, el paciente acude al mostrador a confirmar su asistencia. En ese momento se le comunica la sala de espera a la que debe acudir, y cualquier otra observación que se precise. En la sala de espera, el personal encargado de ello va avisando a los pacientes para que entren a consulta. Ese mismo personal registra también la asistencia del paciente.

- El médico atiende al paciente y elabora el informe de la consulta. Además, puede expedir recetas o volantes para una prueba adicional en el servicio que sea necesario.

- Cada médico o servicio, al finalizar la jornada, debe entregar en recepción la programación del día con las asistencias de los pacientes a su consulta anotadas en ella. Ese documento se almacenan para su posterior análisis —cuántas citas confirmadas, cuántas asistencias finales a consulta—.

2. **Urgencias en un Hospital General**

- Una vez haya dado sus datos, le llamarán de la consulta de Triaje o RAC (Recepción, Acogida, y Clasificación), donde el personal de enfermería le realizará unas preguntas básicas y unos procedimientos siguiendo un programa informático específico. Posteriormente, en la consulta con el médico, usted podrá ampliar toda la información y entregarle la documentación que aporte.
- Se le identificará con una pulsera y se entregará a su acompañante una tarjeta de permanencia y acceso.
- La atención médica será en función de la prioridad clínica y la especialidad (urgencias generales, urgencias traumatológicas, urgencias oftalmologicas, etc.) y no por el orden de llegada a la unidad.
- Se le indicará la zona en la que se va a ubicar:
    - sala de espera de nivel 1 para pacientes asignados a consultas ambulantes y de traumatología.
    - boxes o zona de encamados
- Una vez atendido por el médico asignado, el personal de enfermería le realizará y cursará las pruebas solicitadas. Los tiempos en obtener los resultados son variables.
- El médico le atenderá nuevamente, una vez que estén los resultados, para darle información sobre su diagnóstico.

- El diagnóstico conlleva las acciones comunes en estos casos: prescripción de tratamiento, observación, ingreso hospitalario o alta.

3. **Quirófano**

a) Modela el proceso que se detalla aquí. Una primera versión simple, generalista, sin excepciones ni símbolos complejos.

b) La segunda versión, algo más detallada, ya debería incluir sendas dentro de cada proceso y tareas más concretas.

c) La tercera versión, y sucesivas si hiciera falta, pretende ser completamente operativa, con las tareas caracterizadas como manuales, de servicio, etc.

Descripción del caso

- Se trata del caso de intervenciones quirúrgicas con ingreso hospitalario que precisa anestesia. Se entiende que la decisión ya ha sido tomada y vamos a describir lo que ocurre después.

- El servicio de cirugía programa una intervención para un paciente (fecha y hora), solicita una pruebas preoperatorias y proporciona al paciente unas indicaciones de cómo debe proceder hasta el día de la operación.

- El paciente es citado para una consulta de preanestesia, por el servicio de anestesiología. El paciente lleva los resultados de las pruebas preoperatorias y el facultativo decidirá si los resultados permiten continuar con la intervención.

- Si la valoración es negativa, el paciente no es apto para operarse, le indicará el porqué y pedirá nuevas pruebas. El paciente debe realizarlas y llevar los resultados de nuevo al servicio de cirugía para que se programe una nueva fecha para la operación.

- Si la valoración es positiva, se le pedirá un consentimiento informado y nuevas indicaciones preoperatorias.

- Cuando el paciente pasa por admisión y es ingresado, enfermería realiza nuevas pruebas de control que, de ser negativas, podrían cancelar o retrasar la operación.

- Si todo es correcto, celadores llevan al paciente a la zona de espera, donde enfermería vuelve a comprobar que todo sea correcto.

- El celador pasará entonces al paciente a quirófano donde enfermería de quirófano y anestesiología realizan el checklist. Podría darse el caso de que esta comprobación fuera negativa y se debe decidir si cancelar, retrasar o continuar.

- Operado el paciente, se cumplimentan los informes quirúrgico, anestésico y de enfermería. Estos informes son la base para decidir si el paciente pasa a recuperación postanestesia o a UCI.

- Finalmente un celador se lleva al paciente y el quirófano se limpia por el personal de limpieza.